

إسم المريض رابعياً : فاطمه مصطفى محمد منصور

المحافظة : الجيزة **الحي / المدينة : الجيزة**

رقم البطاقة : 28306082100145 رقم التليفون : 01229662981

العمر(تاريخ الميلاد) : 08-06-1983 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----)

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضى الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

التعليق على التشخيص : -----

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: _____
 الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: _____
 الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: _____
 أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
 وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
 كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جھة العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فاطمه مصطفى محمد منصور National ID: 28306082100145	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

١٩٩٥٠٠٩٢٢١
١١١٠٠١٠٩٩٣

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



فاطمة

مصطفى محمد منصور عثمان

١٤ ح عيد من ش ابوسليم

الجيزة - الجيزة

٢٨٣٠٦٠٨٢١٠٠١٤٥

IG3813737

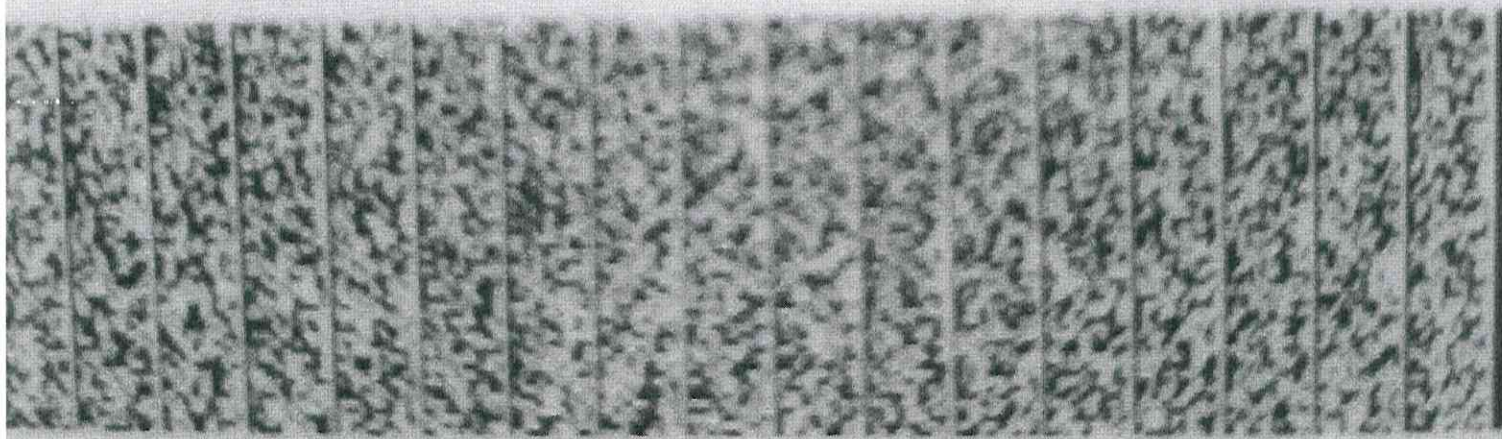
٢٠١٩/١١ ٢٨٣٠٦٠٨٢١٠٠١٥٥

حاصلة على بكالوريوس تجارة

انثى مسنة متروجة

عباس حسين عبدالجبار احمد

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/١١/٢٣



Name: فاطمة مصطفى محمد		
MR. : 6492		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient presented on 31 January 2026 for initiation of letrozole (Femara) with one month of supplemental therapy and a 10.8 mg annual dose of goserelin (Zoladex) for breast cancer management, with a baseline breast-sparing assessment (BSM) performed. On 27 April 2026 the oncology team documented a case of breast cancer on adjuvant aromatase inhibitor therapy with goserelin. A suspicious lesion was identified in the right breast measuring 1.2 × 1.3 cm, classified as BI-RADS 4A, and a tru-cut biopsy was performed. On 20 July 2026 the patient reported hot flushes and generalized bony pain. Physical examination was otherwise unremarkable except for a 1 × 1 cm subcutaneous nodule at the medial end of a scar, which was biopsied in May 2026 and diagnosed as fat necrosis. Goserelin was administered today and hormonal therapy was continued. The patient was also scheduled for zoledronic acid every six months, a baseline breast ultrasound (BBUS) due 10 October 2026, a pelvic ultrasound (PAUS), a DEXA scan, and laboratory testing for lipid profile and vitamin D.		
تحريراً في ,		
	التاريخ : 20-09-2026	الوقت :
Reham Ahmed Fathy Ibrahim		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient's Name: FATMA MOSTAFA
Date: 2026-04-26
Referred by: Prof.Dr
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after right conservative surgery.

- Breast density: Predominant fatty tissue ... Matching ACR A.
- Focal asymmetry is seen in the right upper outer quadrant with multiple small fat containing lesions are seen in the right upper outer quadrant.
- A small subcutaneous lesion related to the operative bed is seen in the right UOQ with suspicious microcalcifications is seen.
- No detected suspicious mass density, architectural distortion or pathological micro-calcification in left breast.
- Normal skin and nipple on the left breast.

By complementary bilateral breast ultrasound:

- Homogenous (predominantly fatty) parenchymal echo-texture of both breasts.
- Thickened right breast skin 5 mm in thickness Clear operative bed on the right upper outer quadrant with small subcentimetric lesions of traumatic fat necrosis.
- Another subcutaneous lesion is seen at 11 o'clock position zone 3 of the right breast with suspicious microcalcifications .it measures (12 x 13 mm).
- No detected significant axillary lymph nodes.

CONCLUSION:

- Post conservative surgery changes of the right breast with indeterminate nature subcutaneous lesion for pathological confirmation (BIRADS 4A Category).
- Normal left breast (BIRADS 1 Category).

MUCH OBLIGED

Prof.DR.MONA ZAKY